

Avaliação pré-operatória · risco e jejum

Pré-operatório bem feito reduz cancelamento e evento CV. Estime risco do paciente × risco do procedimento; peça exames só se mudarem conduta.

Risco cardíaco

Dica - Risco cardíaco

Procedimento de risco alto + fatores clínicos (DAC, IC, DM, IRC, AVC) !' avaliação adicional.

Emergência opera com otimização possível — não atrase trauma/peritonite por 'check-up completo'.

Organize: otimizar comorbidades !' suspender/manter drogas !' jejum !' ATB na indução.



Drogas e jejum

- Manter betabloqueador e estatina se já em uso crônico (em geral)
- IECA/BRA: muitos protocolos suspendem no dia (hipotensão anestésica)
- Metformina: suspender em risco de hipoperfusão/contraste — evitar acidose láctica
- Jejum: 8/6 h sólidos (conforme guia) e 2 h líquidos claros

Profilaxia antimicrobiana

Cirurgia | Exemplo clássico

Limpa com prótese | Cefazolina

Digestiva alta/baixa | Cobertura anaeróbia conforme sítio

Via biliar | Cefazolina ± Gram"

Alergia grave a beta-lactâmico | Clinda ± vancomicina / protocolo

Armadilha de prova

Atencao - Armadilha de prova

ATB profilática deve estar na pele antes da incisão (janela ~60 min; vancomicina mais cedo). Dose única costuma bastar — não 'prolonge 7 dias' sem infecção.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1